



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متدد

إسم المريض ربيعاً : فتية حامد احمد حامد

العنوان :

الحى / المدينة : دار السلام

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

رقم البطاقة : 26908190104567 رقم التليفون : 01151901359

العمر(تاريخ الميلاد) : 19-08-1969 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / أ.د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: فتحية حامد احمد حامد
National ID: 26908190104567



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ ومساءة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ ومساءة الدخول :
--:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

الوقت :

--:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحليل الشخصية

فتحية
حامد احمد حامد
مركز ومن
دار السلام - القاهرة

١٩٦٩/٠٨/١٩ ١٩٦٩/٠٨/١٩ ١٩٦٩/٠٨/١٩ ١٩٦٩/٠٨/١٩

LB7951349

٢٠٢٥/٠٩/٢٥ ٢٠٢٥/٠٩/٢٥ ٢٠٢٥/٠٩/٢٥ ٢٠٢٥/٠٩/٢٥

رئة ملزلة
الشي

البطاقة متارية حتى ٢٠٢٥/٠٩/٢٥



Handwritten signature and stamp

Patient Name : الأستاذة / فتحية حامد احمد
Patient No. : 26908190104567
Path No. : 5247/24
Sex : Female
Age : 55 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009862
Request Date : 30/12/2024
Verification Date : 16/01/2025
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data
Right breast mass

Nature of specimen
Tru cut biopsy, collected at 29/12/2024, 10:30 am

Gross examination
Multiple grayish white tissue cores up to 2 cm, totally submitted.
IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination
* Histological type: Invasive duct carcinoma
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II
* DCIS: No
* Angiolinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
* Perineural invasion: No
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
* ER: Strong nuclear reaction in 80 % tumor cells (Allred score 8/8)
* PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
* HER2: No membrane reaction in of tumor cells (score 0)
* Ki 67: 30 % nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis
Right breast mass, Tru cut biopsy:

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 19/01/2025 09:09:45

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



Name:	فتحيه حامد احمد	
MR. :	4365	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
رقم طبي:		بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
MBC to liver on faslodex , ibramce came today for C 4 falodex, ibrance 125 mg labs >>> OK new assessment >>> R Pt is a 60 yrs old female pt, Denovo MBC to LNs and liver, HR+ Her2-, under 2nd line Faslodex/Ibrance, last received in 3/2026 then stopped ?? DP (CT CAP 26/3/2026...progressive course of Rt AxLNs, otherwise SD). C/o.....abdominal pain & vomiting O/e.....Tender hepatomegaly with diffuse scratch marks (??allergic) For... 1.Labs 2.MDT to consider U/S-guided biopsy from HFL & shifting to cth. still waiting for result of rebiopsy mri brain requestd LFT requested new ct scan showed multiple bilobar HFL bx ER 6/8 PR 0/8 HER 2+ SISH NOT AMPLIFIED PLANNED FOR TAXOL CARBO Patient is in hepatic visceral crises to start carboplatin AUC 2 today for week 1 taxol carbo auc 2 labs outside accepted bil t/d 2.6/22 paus moderate ascites + multiple hfls pt is neutropenic fever tlc 0.38 plt 24 lft normal bp 100/70 for broad spectrum abs and repeat cbnc tommorrow no place for admission pt received 2 w taxol/ carbo today visit pt improved to continue her antibiotics at ER with follow up cbc and for OPC for continuation her systemic ttt relative said pending approval of bx from liver wt 69 (dry wt mod ascites 63 ht 155 sa 1.6 postmenop rt breast cancer met to liver l nodes idc 2 er6/8 pr0/8 her22+ sish not amplified rec ai from 3/2025 till11/2025 dp rec fasoldex ibrance for 3 m dp visceral crisis cts 30/6 rt breast mass m 52x24 mm minimal rt pleural eff multiple bilobar hfl largest m 13x8.4 abd lymph nodes pt rec 2 weeks taxol carbopl then grade 3 neutropenia thrombocytopenia neutropenic fever and was admitted in er then last week hepatic precoma ct brain free and admitted in icu on exam ll edema hepatomegal bilat ax ln 1x2 rt breast m,ass 3x3 for new labs for 205 dr and 1 proph neupogen and assess tolerance for w3 taxol 95 mg carbopl auc 1.5 and 1 proph neupogen hfl biopsy pending for ll venous duplex wt 69 (dry wt mod ascites 63 ht 155 sa 1.6 postmenop rt breast cancer met to liver l nodes idc 2 er6/8 pr0/8 her22+ sish not amplified rec ai from 3/2025 till11/2025 dp rec fasoldex ibrance for 3 m dp visceral crisis cts 30/6 rt breast mass m 52x24 mm minimal rt pleural eff multiple bilobar hfl largest m 13x8.4 abd lymph nodes pt rec 2 weeks taxol carbopl then grade 3 neutropenia thrombocytopenia neutropenic fever and was admitted in er then last week hepatic precoma ct brain free and admitted in icu on exam ll edema hepatomegal bilat ax ln 1x2 rt breast m,ass 3x3 for new labs for 205 dr and 1 proph neupogen and assess tolerance for w3 taxol 95 mg carbopl auc 1.5 and 1 proph neupogen hfl biopsy pending for ll venous duplex t bil		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
حنان عزت شفيق ناودروس		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

1.48

patient received 3 weeks of carboplatin rebiopsy still luminal improvement of bilirubin however the patient developed severe neutropenia after week 2
tol bil 2.8 on 8/8 to continue carboplatin AUC 1.5 with close FU of LIVER FUNCTIONS

Pharmacy Visit Wt: 63, Ht: 155, AdBwt: 53.9 For W4 Carboplatin AUC 1.5 Labs 8/8 ... accepted

for w5 taxol cap at 100 mg + carboplatin auc 1.5, labs accepted, ondalenz + mebasel + ppi

hfl biopsy on 15/8/2026 er6/8 pr0/8 her2-ve +1 for w6 taxol 100 carboplatin auc 1.5 and blood transfusion

for taxpl capped at 100 mg + carbo auc 1.5, for liver support + PPI + ondalenz

Patient Name : الأستاذة / فتحية حامد احمد
Patient No. : 26908190104567
Path No. : 5247/24
Sex : Female
Age : 55 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009862
Request Date : 30/12/2024
Verification Date : 16/01/2025
Financial Category : اورام دار السلام - مبادر
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Invasive duct carcinoma, Grade II
IPT:

- * ER: Positive (score 8/8).
- * PR: Negative (score 0/8).
- * HER2: Negative (score 0).
- * Ki67: Positive in 30% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Amal hareedy
Dr. i lebr

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 19/01/2025 09:09:45

Page 2 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

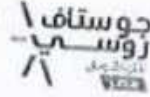
Patient's Name: fathia hamid ahmed hamid
Date: 2026-03-26
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**
as compared to previous study dated 30/11/2025, the current study reveled
I- CHEST:

- o Stationary course of the right breast UOQ mass lesion measuring 53x24mm
- o Progressive course of the right axillary lymph nodes level I,II&II , the largest measures 30 x 20 mm at the current study compared to 24x17mm at the previous study
- o Stationary course of the right internal mammary LN measures 14x10mm
- o Stationary course of the scattered pulmonary nodules, the largest is at right upper lobe measures 7mm
- o Right pulmonary middle lobar consolidation with associated septal thickening.
- o No consolidation or collapse.
- o Still seen prominent medistinal LNS.
- o No pleural or pericardial collection.
- o Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- o Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No dilated biliary radicles. Multiple bilobar focal lesions, with no appreciable changes regading the confluent lesion seen at segment V measuring 40X30mm showed faint marginal enhancement in the delayed phase
- o Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- o Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- o The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- o Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- o No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- o No ascites.



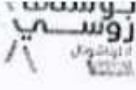
Patient's Name: fathia hamid ahmed hamid
Date: 2026-03-26
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Opinion:

- ❖ Stationary course of the right breast irregular soft tissue lesion
- ❖ Progressive course of the right axillary LNS
- ❖ Stationary course of the right internal mammary LN
- ❖ Stationary course of the hepatic focal lesions
- ❖ Rather stationary rest of study

Dr.Assem Ahmed

Dr.Assem Ahmed


Patient's Name: fathia hamid ahmed hamid
Date: 2026-03-26
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

I- CHEST:

- Known case of right breast cancer showed right breast mass lesion measuring 43 x 35 mm with right axillary lymph nodes, the largest measures 30 x 20 mm
- Right pulmonary middle lobar consolidation with associated septal thickening.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No dilated biliary radicles. Multiple bilobar focal lesions, the largest seen in the right hepatic lobe (segment V) hypodense focal lesion measuring 43 x 33 mm showed faint marginal enhancement in the delayed phase
- Both kidneys are normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- ❖ Known case of right breast cancer showed right breast mass with axillary lymph nodes.

Patient Name	فتحية حامد احمد	Age	55 y
Sex		Special habits	
Family History		Comorbidity	
Surgical History		Telephone	01129086536
Menopausal Status		Marital Status	
ID	26908190104567	Medical ID	198/2025
Date	15-10-2025	Reason for MDT	

Medical Report

Affected breast:
Right breast

Pathology: IDC2

ER 8/8. PR 0/8. HER2 0 Ki 67 30%

T3 N1 M liver :

S.M:

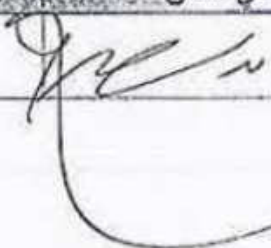
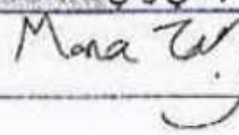
Metsworkup:

Doctor's notes:

CT CAP 17/8/2025 → PD of Rt axillary axillary LN's with SD of liver.

Bone scan requested & MDT to consider shifting to 2nd line faslodex/ibrance.

MDT DECISION	CT revision by radiodx confirmed progression of HFL For Ibrance/faslodex
--------------	---

Name	د/ ندي حسن	د/ مني زكي
Signature		



Patient Name: Fat'heya Hamed Ahmed Hamed	Date : 26/12/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 26908190104567	Pat. ID: 95697

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Right breast palpable lump, over the past 10 days.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Right breast shows UOQ spiculated irregular mass lesion, of high density.
- Complementary ultrasound revealed right breast irregular hypoechoic mass with angular margins, with subtle vascularity detected within on color Doppler, seen at 10 o'clock position 2cm from the nipple, 0.5cm from the overlying skin, measuring 2x4.5cm, consistent to the palpable lump.
- No left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Indeterminate right axillary lymph node seen with focal thickness reaching 3mm
- Free right infra and supra-clavicular regions
- Nonspecific left axillary LN.

Opinion:

- Right breast UOQ malignant looking mass lesion (BIRADS 5) for histopathological correlation.
- Indeterminate right axillary LNs.
- No left breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

26/12/2024 2:25 PM



Patient Name: Fat'heya Hamed Ahmed Hamed	Date : 14/04/2025
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 198/2025	Pat. ID: 95697

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Mildly enlarged in size (16.8cm at Rt MCL) bright parenchymal echopattern with bilobar multiple discrete and confluent hypoechoic focal lesions, the largest is 7x4.5 cm seen at segment V.
- No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

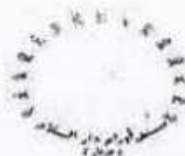
Uterus and adnexal: no abnormalities could be detected

Opinion:

Bright hepatomegaly likely fatty with bilobar focal lesions likely metastases

Signature Dr . Nermien Ramadan

14/04/2025 1:41 PM



Patient Name: Fat'heya Hamed Ahmed Hamed	Date : 03/02/2025
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 188/2022	Pat. ID: 95697

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Right breast UOQ irregular soft tissue mass lesion ,maesures about 5 x2.8 cm .
- Right axillary prominent lymph nodes level I ,II, the largest measures about 1.5 1 cm at level I.
- Right interal mammary lymph nodesm measures about 10x5 mm.
- Bilateral basal lung and lateral segement of middle lobe reticulations .
- No sizabic pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver Is of average size with hoterogenous CT texture, seen studded with bilobar variable sized confluent hypodense focal lesions, the largest confluent seen at segement V , measures about 7.7x 3.3 cm.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.

Patient Name: Fat'heya Hamed Ahmed Hamed	Date : 17/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 198/2025	Pat. ID: 95697

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Mild regressive course of right breast UOQ irregular soft tissue mass lesion ,maesures about 4.2 x2.1 cm compared to 5 x2.8 cm at last study.
- Mild progressive course of right axillary prominent lymph nodes level I,II, the largest measures about 1.9 x1.5 cm compared to 1.5 x1 cm at level I priorly .
- No appreciable chanes Right interal mammary lymph nodes measures about 9x6 mm comapred to 10x5 mm.
- Bilateral basal lung and lateral segement of middle lobe reticulations .
- Mosiac perfusion of both lung lobes predominanately basal .
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with hoterogenous CT texture, seen studded with bilobar variable sized confluent hypodense focal lesions, no appreciable changes reagarding the largest confluent seen at segement V , measures about 7.7x 3.3 cm.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen. With small splenule 8 x8 mm.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

No definite worrisom osseous lesion.

Opinion:

- Mild regressive course regarding right breast mass lesion, with mild progression of size ipsilateral prominent axillary lymph nodes .
- Rather stationary rest of study

Dr/Reham khedr, M.D.

Signature Reeham.Khader
21/08/2025 1:14 AM

2025/12/8

Name: Mrs. fathlya hamid

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:
Clinical summary: Right breast cancer, on hormonal therapy

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ , two speculated irregular high density mass lesion with surrounding distortion, with associated retracted nipple
- Ultrasound demonstrated 9-10 o'clock, zone b , irregular spiculated heterogenous hypoechoic solid mass lesion with surrounding echogenic halo, and mild internal vascularity on color Doppler study measuring 33 x 20 mm.as well as another adjacent similar one at 9 oclock zone b measuring 28 x 17 mm
- Normal nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated heterogeneous breast with mottled appearance with no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 6):. Pathologically proven breast carcinoma

Left breast (BIRADS 1): Normal study.

Dr farah elshobaky

***Scanned skeleton:**

No definite worrisome osseous lesion.

Opinion:

- Progressive course of right breast UOQ irregular soft tissue mass lesion .
- Progressive course of right axillary prominent lymph nodes and internal mammary lymph nodes .
- Few scattered bilateral pulmonary nodules for follow up.
- Regressive course regarding size of hepatic focal lesions
- Rather stationary rest of study

Dr/Reham khedr, M.D.

Signature reham kheder
30/11/2025 11:23 PM

Diet Type: Vegetarian

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

Blood / Blood Components Transfusion Consent

اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

4393	الرقم الطبي:
مصلحة عامة / اسم	اسم المريض:
19/08/1989	تاريخ الميلاد:
198/75	الرقم الطبي:

2024/03/03

الرقم الطبي: التشخيص: رقم قومي / جواز سفر: تاريخ: 2024/03/03

انني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته وذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح ومفهوم:

1- حسب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالباً ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب

الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالباً ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الاضطرابات أو

فشل الكبد.

د- الفوائد المتوقعة من هذا الإجراء

أ- المضاعفات المحتملة بما في ذلك:

الردود الفعل التحسسية التي قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب- ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بأمراض فيروسية و بكتيرية.

د- مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة قلة السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ- حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن

حدث في القلب أو الكبد.

و- إصابات بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعددة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

ز- الدلائل الممكنة لنقل الدم إن وجدت.

هـ- حقني في طرح الأسئلة والحصول على الإجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

أقر أنا الموقع أدناه (المريض / ممثل القانوني) أنني قد فهمت كل مشتقات هذا الإقرار و التحصل المسؤولية كاملة عن كل ما فيه

اسم المريض (أو محله القانوني): اسم الطبيب المعالج / الرقم الوظيفي: تاريخ: 2024/03/03

الدرجة القرارية: التوقيع:

رقم قومي / جواز سفر: التاريخ / الوقت:

التوقيع: التوقيع:

اسم الشاهد: التاريخ / الوقت: 2024/03/03

رقم قومي / جواز سفر: التوقيع:

التوقيع: التوقيع:

اسم الشاهد: التاريخ / الوقت: 2024/03/03

رقم قومي / جواز سفر: التوقيع:

التوقيع: التوقيع:

اسم الشاهد: التاريخ / الوقت: 2024/03/03

رقم قومي / جواز سفر: التوقيع:

التوقيع: التوقيع:

Blood Delivery form

Patient name:	فؤاد جلال احمد
MRN:	198/2025

رقم الطلب 198/2025

Components	Amount	Order Status	Time of Order
☐ Whole blood		☐ Scheduled	
☐ Packed RBCs	One Unit	☐ Emergency	
☐ Filtered Packed RBCs		☐ High Emergency (without tcross matching)	
☐ Irradiated Packed RBCs		☐	
☐ Fresh Frozen Plasma		☐	
☐ Platelet concentrate		☐	
☐ Cryo precipitate		☐	
☐ Irradiated Platelet		☐	

Time of Delivery of Blood Components:

4:01:02 p

Blood Group:

(A)

RH Group (D antigen):

Positive

Antibody Screening:

Cross Matching:

Matched

Bag No.:

2634

A4969282

Donation time

EXPIRATION DATE

13/8/2026

17/9/2026

Donation time

EXPIRATION DATE

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
HOSSAM HARON		25-2026 أغسطس	4:01 p

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
Amr Mohamed	Amr Mohamed	25-2026 أغسطس	4:01 p

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no: 1168	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age: 30
Diagnosis: 1168		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion: ☐ No ☐ Yes		
History of Previous Blood Transfusion Reaction: ☐ No ☐ Yes, specify.....		
Number of Units Needed:	To be delivered to:	
☐ Whole Blood..... Units	☐ OR	
☐ Packed Cells..... Units	☐ ED	
☐ Platelets..... Units	☐ ICU	
☐ F.F.P..... Units	☐ BMT	
☐ Cryoprecipitate..... Units		
☐ Auto transfusion..... Units		
☐ Other:..... Units		
Urgency: ☐ Immediate: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ Urgent: Cross matching tests take 1 hour ☐ Routine: compatibility test take two hours	Frequency of Transfusion:	
Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date: Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date: Time:

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

Blood Transfusion Monitoring Form

Patient name: Yusuf
MRN: 4365

Date of delivery: 25.1.2025 Time of delivery: 1:30 Transfusion start time: 14:10 End Time: 15:10
Blood Group & RH Type: (A+) Type of blood unit: (A+) Blood unit No: 2634

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: <u>Mona Said 3059</u> Signature: <u>Mona Said</u>	☐ Charge Nurse	Name & ID: <u>Yusuf Said 3012</u> Signature: <u>Yusuf Said</u>
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: <u>Mona Said 3059</u> Signature: <u>Mona Said</u>	☐ Charge Nurse	Name & ID: <u>Yusuf Said 3012</u> Signature: <u>Yusuf Said</u>

Nursing Observation: ☒ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☒ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	4,10	36-6	82	100	16	110/70	0
After 5 minutes	4,15	36-5	84	99	16	110/72	0
After 10 minutes	4,20	36-6	85	99	17	115/75	0
After 15 minutes	4,25	36-7	84	100	18	116/80	0
After 30 minutes	4,40	36-6	83	99	16	120/82	0
After 45 minutes	4,55	36-7	88	98	16	119/81	0
After 60 minutes	5,10	36-7	90	92	17	120/79	0
After 90 minutes	5,40	36-8	92	95	16	122/80	0
After completion of transfusion	6,10	36-7	92	100	17	124/84	0
After 5 minutes from completion of transfusion	6,15	36-9	92	98	18	123/85	0
After 1 hour from completion of transfusion	7,10	36-9	93	98	19	122/83	0
After 2 hours from completion of transfusion	8,10	36-8	90	98	20	120/82	0

Nurse Name & ID: Mona Said 3059 Signature: Mona Said Date: 25.1.2025 Time: 15:10 PM
* Use separate form for each unit transfused.

Diet Type: Vegetarian

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

Blood / Blood Components Transfusion Consent

اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

4393	الرقم الطبي:
صحة عامه	اسم المريض:
19/08/1989	تاريخ الميلاد:
198/75	الرقم الطبي:

2024/03/03

الرقم الطبي: رقم قومي / جواز سفر التشخيص:
أقر أنا الموقع أدناه (المريض / ممثل القانوني)
أنني قد وافقت على إعطاء الدم و/أو أحد مشتقاته وذلك بعد أن قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح ومفهوم:

أ- حسب الحاجة إلى نقل الدم في حالات:

1- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالباً ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

2- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب

الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالباً ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الاضطرابات أو

فشل الكبد.

د- الفوائد المتوقعة من هذا الإجراء

هـ- المخاطر والمضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ- ردود الفعل التحسسية التي قد تشمل طفح جلدي، حمى، أو تورم.

ب- ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بأمراض فيروسية و بكتيرية.

د- مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة قلاء السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ- حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن

حدث في القلب أو الكبد.

و- إصابات بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعددة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

ز- الدلائل الممكنة لنقل الدم إن وجدت.

ح- حقني في طرح الأسئلة والحصول على الإجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

أقر أنا الموقع أدناه بأنني على كامل المعرفة والفهم لكل مشتقات هذا الإقرار. وتحصل المسؤولية كاملة عن كل ما فيه

اسم المريض (أو محله القانوني): اسم الطبيب المعالج / الرقم الوظيفي:
الدرجة القرارية: التوقيع:
رقم قومي / جواز سفر: التاريخ / الوقت:
التوقيع:
اسم المشاهد:
التاريخ / الوقت:
رقم قومي / جواز سفر:
التوقيع:

Patient name:	فادية حاتم احمد
MRN:	198/2025

Blood Delivery form

رقم الطلب 2103 2025

Components	Amount	Order Status	Time of Order
☐ Whole blood		☐ Scheduled	
☐ Packed RBCs	One Unit	☐ Emergency	
☐ Filtered Packed RBCs		☐ High Emergency (without tcross matching)	
☐ Irradiated Packed RBCs		☐	
☐ Fresh Frozen Plasma		☐	
☐ Platelet concentrate		☐	
☐ Cryo precipitate		☐	
☐ Irradiated Platelet		☐	

Time of Delivery of Blood Components:

4:01:02 p

Blood Group:

(A)

RH Group (D antigen):

Positive

Antibody Screening:

Cross Matching:

Matched

Bag No.:

2634

A4969282

Donation time

EXPIRATION DATE

13/8/2026

17/9/2026

Donation time

EXPIRATION DATE

Blood Bank Physician
Name & ID

Signature

Date of Delivery

Time

HOSSAM HARON

HOSSAM HARON

25-2026 أغسطس

4:01 p

Assigned Nurse/
Healthcare Assistant
Name & ID

Signature

Date of Delivery

Time

Amr Mohamed

Amr Mohamed

25-2026 أغسطس

4:01 p

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no: 1168	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age: 50
Diagnosis: 1168		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion: ☐ No ☐ Yes		
History of Previous Blood Transfusion Reaction: ☐ No ☐ Yes, specify.....		
Number of Units Needed:	To be delivered to:	
☐ Whole Blood..... Units	☐ OR	
☐ Packed Cells..... Units	☐ ED	
☐ Platelets..... Units	☐ ICU	
☐ F.F.P..... Units	☐ BMT	
☐ Cryoprecipitate..... Units		
☐ Auto transfusion..... Units		
☐ Other:..... Units		
Urgency: ☐ Immediate: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ Urgent: Cross matching tests take 1 hour ☐ Routine: compatibility test take two hours	Frequency of Transfusion:	
Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date: Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date: Time:

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

Blood Transfusion Monitoring Form

Patient name: Yusuf
MRN: 4365

Date of delivery: 25.1.2025 Time of delivery: 1:30 Transfusion start time: 14:10 End Time: 15:10
Blood Group & RH Type: (A+) Type of blood unit: (A+) Blood unit No: 2634

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: <u>Mona Said 3059</u> Signature: <u>Mona Said</u>	☐ Charge Nurse	Name & ID: <u>Yusuf Said 3012</u> Signature: <u>Yusuf Said</u>
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: <u>Mona Said 3059</u> Signature: <u>Mona Said</u>	☐ Charge Nurse	Name & ID: <u>Yusuf Said 3012</u> Signature: <u>Yusuf Said</u>

Nursing Observation: ☒ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☒ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	4,10	36-6	82	100	16	110/70	0
After 5 minutes	4,15	36-5	84	99	16	110/72	0
After 10 minutes	4,20	36-6	85	99	17	115/75	0
After 15 minutes	4,25	36-7	84	100	18	116/80	0
After 30 minutes	4,40	36-6	83	99	16	120/82	0
After 45 minutes	4,55	36-7	88	98	16	119/81	0
After 60 minutes	5,10	36-7	90	92	17	120/79	0
After 90 minutes	5,40	36-8	92	95	16	122/80	0
After completion of transfusion	6,10	36-7	92	100	17	124/84	0
After 5 minutes from completion of transfusion	6,15	36-9	92	98	18	123/85	0
After 1 hour from completion of transfusion	7,10	36-9	93	98	19	122/83	0
After 2 hours from completion of transfusion	8,10	36-8	90	98	20	120/82	0

Nurse Name & ID: Mona Said 3059 Signature: Mona Said Date: 25.1.2025 Time: 15:10 PM
* Use separate form for each unit transfused.